

REFERTI SPECIALISTICI ESTERNI (ALLEGATI)

Referto N. 1: Eco-Color-Doppler Tronchi Sovraortici (TSA)

- **Data Esame:** 02/11/2023
- **Sede:** Ambulatorio di Angiologia, Ospedale "Lothlórien"
- **Medico Refertante:** Dott. Celeborn
- **Quesito Diagnostico:** Soffio carotideo sinistro.
- **Tecnica:** Eco-Color-Doppler TSA con sonda lineare 7-12 MHz.
- **Referto:**
 - **CAROTIDI COMUNI (CCA):** Lieve ispessimento diffuso IMT (dx 1.0 mm, sn 1.1 mm).
 - **CAROTIDI INTERNE (ICA):**
 - **Destra:** Pervia, non placche. Flussi normali (PSV 78 cm/s).
 - **Sinistra:** Pervietà conservata. **PLACCA ATEROSCLEROTICA** all'origine, parete posteriore.
 - **Morfologia:** Fibro-calcifica.
 - **Superficie:** Regolare, non ulcerata.
 - **Stenosi:** Quantificata con metodo ECST: **circa 30% (stenosi lieve)**.
 - **Parametri emodinamici:** PSV 110 cm/s (lieve aumento, <125), Rapporto ICA/CCA 1.6 (<2). Stenosi NON emodinamicamente significativa.
 - **CAROTIDI ESTERNE (ECA):** Pervie, non stenosi.
 - **ARTERIE VERTEBRALI:** Pervie, flusso anterogrado (normale). Non "steal syndrome".
 - **ARTERIE SUCCLAVIE:** Pervie.
- **Conclusioni:**
 1. Quadro di aterosclerosi carotidea diffusa bilaterale.
 2. **Placca aterosclerotica fibro-calcifica carotide interna SINISTRA, determinante stenosi LIEVE (30% ECST), non emodinamicamente significativa, superficie regolare.**
 3. Assenza di altre stenosi significative.
- **Commento e Raccomandazioni:**

Reperto coerente con aterosclerosi iniziale-moderata. Basso rischio emboligeno attuale.

 - Stretto controllo FdR (target LDL <100 mg/dL, controllo PA).
 - Considerare terapia antiaggregante (ASA o Clopidogrel). [Nota: Paziente ora in Clopidogrel].
 - Follow-up Eco-Doppler TSA a 12 mesi.

(Firma Digitale: Dott. Celeborn)

Referto N. 2: Visita Ematologica Specialistica

- **Data Visita:** 15/06/2024
- **Sede:** Ambulatorio di Ematologia, Ospedale "LothlóRIEN"
- **Medico Refertante:** Dott.ssa Tauriel
- **Quesito Diagnostico:** Piastrinosi persistente (PLT 430.000/ μ L). Esclusione patologia mieloproliferativa.
- **Anamnesi:** Paziente asintomatica. Riscontro occasionale di PLT 410k-430k. Nega sintomi sistemici, trombosi, emorragie. APR nota (ipercolesterolemia, carotidopatia 30% sn, enfisema).
- **Esame Obiettivo (Ematologico):**
 - BCG. Non pallore, non pletora. Non petecchie.
 - Non linfadenomegalie.
 - Addome: Fegato non palpabile. **Milza NON SPLENOMEGALIA.**
- **Esami di Laboratorio Visionati:**
 - **Emocromo (Giugno 2024):** WBC 7.100, Hb 13.0, Hct 39.8, MCV 92.0, **Piastrine (PLT) 425.000 / μ L (AUMENTATE).** Formula leucocitaria normale.
 - **Striscio periferico:** Piastrine aumentate di numero, morfologia normale.
 - **Indici di flogosi:** VES 16 mm/h (limiti alti), PCR 0.8 mg/dL (lievemente aumentata).
 - **Assetto marziale, Vit B12, Folati:** Nella norma.
 - **Esami molecolari (Maggio 2024):**
 - **Ricerca mutazione JAK2 V617F: NEGATIVA**
 - **Ricerca trascritto BCR-ABL: NEGATIVO**
 - **Ecografia addome (Maggio 2024):** Fegato normale. **Milza: Dimensioni NORMALI** (non splenomegalia).
- **Conclusioni diagnostiche (Dott.ssa Tauriel):**

Il quadro clinico-laboratoristico permette di ESCLUDERE diagnosi di:

 1. **Trombocitemia Essenziale (TE):** Criteri WHO non soddisfatti (PLT <450k, JAK2 negativo, non splenomegalia).
 2. **Policitemia Vera (PV):** Esclusa (Hb/Hct normali, JAK2 negativo).
 3. **Mielofibrosi Primaria:** Esclusa (non splenomegalia, non anemia, JAK2 negativo).
 4. **Leucemia Mieloide Cronica (LMC):** Esclusa (BCR-ABL negativo).

Diagnosi finale: PIASTRINOSI REATTIVA (SECONDARIA) Verosimilmente nel contesto di uno stato infiammatorio cronico di basso grado (cause: aterosclerosi carotidea, scoliosi degenerativa, enfisema). Rischio trombotico da piastrinosi reattiva lieve: basso.
- **Piano terapeutico e Follow-up:**
 - **Terapia specifica per piastrinosi: NON indicata.**
 - **Terapia antiaggregante:** Paziente già in Clopidogrel 75 mg/die per carotidopatia (terapia appropriata, copre anche questo aspetto).
 - **Follow-up:** Controllo emocromo ogni 6 mesi presso MMG.

(Firma e Timbro: Dott.ssa Tauriel)

Referto N. 3: TC Torace ad Alta Risoluzione (HRCT)

- **Data Esame:** 10/01/2020
- **Sede:** U.O. Radiodiagnostica, Ospedale "Lothlórien"
- **Medico Refertante:** Dott. Bilbo Baggins
- **Quesito Diagnostico:** Dispnea da sforzo progressiva. Non fumatrice. Sospetto enfisema.
- **Tecnica:** HRCT senza mdc, acquisizioni in inspirazione ed espirazione forzata.
- **Reperto descrittivo:**
 - **Parenchima polmonare:**
 - Quadro di **enfisema polmonare diffuso bilaterale**, tipo **panlobulare**, di grado complessivamente **lieve-moderato**.
 - **Distribuzione:** Maggiormente evidente ai **lobi superiori bilateralmente**.
 - **Morfologia:** Multiple aree di iperdiafania (ipodensità), confluenti agli apici. Non bolle >1 cm. Rarefazione vascolare ("vascular pruning") agli apici.
 - **Scansioni in espirazione:** Non air-trapping "a mosaico" significativo.
 - **Vie aeree:** Trachea e bronchi principali pervi. Non bronchiectasie, non ispessimenti parietali (non bronchite cronica).
 - **Noduli polmonari:** **Non noduli polmonari solidi o sospetti per neoplasia.**
 - **Interstizio polmonare:** Non ispessimenti settali, non consolidazioni, non fibrosi (non "honeycombing").
 - **Pleure:** **Non versamento pleurico** bilateralmente (seni costofrenici liberi). Non pneumotorace.
 - **Mediastino:** **Non linfadenomegalie mediastiniche.**
 - **Cuore e grossi vasi:** **Ombra cardiovascolare nei limiti.** Calcificazioni aterosclerotiche arco aortico. Arteria polmonare di calibro normale.
 - **Pericardio:** **Non versamento pericardico.**
 - **Diaframma:** Profili **lievemente abbassati e appiattiti** (segno di iperinflazione da enfisema).
- **Conclusioni:**
 1. **Enfisema polmonare panlobulare diffuso di grado LIEVE-MODERATO**, prevalente ai lobi superiori. Compatibile con enfisema in paziente non fumatrice (suggerito dosaggio Alfa-1-Antitripsina, anche se quadro non tipico di deficit severo).
 2. **Non segni di interstiziopatia polmonare.**
 3. **Non lesioni pleuro-parenchimali focali in atto.**
 4. **Non noduli polmonari sospetti.**
 5. **Non linfadenomegalie mediastiniche.**
 6. **Ombra cardiovascolare nei limiti.**
 7. **Diaframma appiattito (iperinflazione).**
- **Raccomandazioni:**
 - Correlazione clinico-funzionale (spirometria, DLCO).
 - Dosaggio Alfa-1-Antitripsina.

- Follow-up clinico-pneumologico.

(Firma Digitale: Dott. Bilbo Baggins)

Referto N. 4: Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) Ginocchio Sinistro

- **Data Esame:** 15/09/2025
- **Sede:** Centro di Diagnostica per Immagini "I Ponti Grigi"
- **Medico Refertante:** Dott. Frodo Samwise
- **Quesito Diagnostico:** Gonalgia sinistra persistente, sospetta lesione meniscale. McMurray positivo.
- **Tecnica:** RM 1.5 Tesla, bobina dedicata ginocchio. Sequenze T1, T2, PD-FS (Proton Density Fat Sat) sagittale, coronale, assiale.
- **Reperto descrittivo:**
 - **MENISCHI:**
 - **Menisco Mediale (MM):**
 - Si documenta **lesione meniscale complessa maggiore**.
 - **Sede:** Corno posteriore, estesa al corpo.
 - **Morfologia:** Lesione di tipo **"a manico di secchio" (Bucket-Handle Tear)**.
 - **Frammento meniscale longitudinale DISLOCATO** (lussato) all'interno della gola intercondiloidea, anteriormente al LCP.
 - **Dimensioni frammento:** Voluminoso (circa 30-35 mm lunghezza, 8-10 mm larghezza), mobile e instabile.
 - **Menisco residuo (muro):** Parzialmente preservato (circa 60-70%). Tessuto residuo con degenerazione (grado III Stoller).
 - **Segni indiretti:** Modesta falda di versamento articolare. Lieve sinovite reattiva. Non edema osseo subcondrale.
 - **Menisco Laterale (ML):**
 - Nei limiti della norma. Integro (grado 0 Stoller).
 - **LEGAMENTI:**
 - **Legamento Crociato Anteriore (LCA): Integro e normoteso.** Non lesioni.
 - **Legamento Crociato Posteriore (LCP): Integro e normoteso.** Non lesioni.
 - **Legamenti Collaterali:**
 - **LCM:** Sostanzialmente integro. Lieve disomogeneità di segnale (edema peri-legamentoso reattivo) adiacente alla lesione meniscale. Non lesione franca.
 - **LCL:** Integro.
 - **CARTILAGINE ARTICOLARE:**
 - **Compartimento Femoro-Rotuleo:**
 - Presenza di **condropatia rotulea** (assottigliamento focale e fissurazione superficiale) sulla faccetta laterale.
 - Grado: **Grado II secondo Outerbridge** (lieve).
 - **Compartimento Femoro-Tibiale Mediale:**
 - Cartilagine **sostanzialmente conservata**. Grado 0-I.
 - **Compartimento Femoro-Tibiale Laterale:**

- Cartilagine **conservata**. Grado 0 (normale).
 - *Conclusione cartilagine*: Ben conservata nei comparti portanti. Condropatia femoro-rotulea lieve.
- **OSSO SUBCONDRALE**:
 - **Non edema midollare osseo** (Bone Marrow Edema - BME).
 - Non lesioni osteocondrali. Non fratture.
- **TESSUTI MOLLI PERIARTICOLARI**:
 - Corpo di Hoffa: Regolare.
 - Borse: Non dilatate. **Non cisti di Baker**.
 - Muscoli e tendini: Integri.
- **Conclusioni**:
 1. **Lesione meniscale complessa tipo "a manico di secchio" (Bucket-Handle Tear) del MENISCO MEDIALE**, con frammento voluminoso **lussato e dislocato** nella gola intercondiloidea.
 - *Commento*: Lesione sintomatica, **indicazione chirurgica** a trattamento artroscopico (meniscectomia selettiva).
 2. **Legamenti crociati (LCA e LCP): integri**.
 3. **Condropatia femoro-rotulea di grado lieve (II)**. Cartilagine femoro-tibiale conservata.
 4. Modesto versamento reattivo.
- **Raccomandazioni**:
 - Indicazione a trattamento chirurgico artroscopico (meniscectomia selettiva).
 - Protocollo riabilitativo post-operatorio.

(Firma Digitale: Dott. Frodo Samwise)